

TEMA 4.11 • DERMATOLOGÍA

Dermatitis Seborreica

PERFIL EUNACOM 6.01.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Dermatitis Seborreica

Se define como un trastorno crónico pápulo-escamoso con carácter de brotes reactivos. A pesar de portar la etiqueta "seborreica", no se produce puramente por una hipersecreción perjudicial de sebo, sino secundario a la inflamación local irritante desatada por la colonización excesiva folicular.

Patogenia Infecciosa Fúngica

Su origen es fúngico dependiente a la sobrecolonización excesiva del hongo levaduriforme lipofílico **Malassezia furfur** (la antigua y obsoleta llamada *Pityrosporum ovale*). Entidad microbiana que asiste concurrentemente como agente vital idéntico causante la recordada infección de espaldas por la mancha de la *Pitiriasis Versicolor*.

Cuadro Clínico Morfopatológico Diferencias Focales

- **Rasgo Morfológico Universal (La placa Amarilla):** Constituye **Placas Eritematodescamativas** recubiertas abundantemente de un manto sucio grasiento característico (**Costras / Escamas Amarillentas muy unidas seborreicas inconfundibles**). - **Topografía Facial / EUNACOM:** Invaden el polo cefálico y lugares alta seborrea. - **Diferencia Vital de Cuero Cabelludo:** Corona masivamente la cuenca superior de la cabeza invadiendo el cráneo escamoso graso, pero su límite sagrado no sobrepasa a la piel libre y la frente abierta respetando anatómicamente de frontera fielmente la "*Línea límite de implantación anatómica y nacimiento de los folículos pelo*". (Este rasgo contrasta y la excluye de la ruda Psoriasis, cuya mancha desborda agresiva invadiéndola). - Afecta intensamente los surcos peri-orificiales aceitosos: **Zona Nasal (Aletas nasales puras perimetrales), Plegues Nasogenianos, la Región media de arco Ciliar y Entre Cajas, Frente medular.**

Paradigma del Tratamiento Médico (División por Edad)

Su enfrentamiento clínico es radical y diametralmente excluyente de prescripción farmacoterapéutica según el tramo de vida poblacional.

- **La Condición Fisiológica del Infante Pediátrico ("Costra Láctea"):**
- - Resulta frecuente en neonatos del 1 al 3er mes como una placa coronaria amarillenta fétida espesa adherida al cráneo inmaduro glandular del lactante sin síntomas molestos ni sangrado.
- - **Terapia Pediatría Exclusiva Oro EUNACOM:** Reposo Médico expectante, abstención total y la "**Exclusiva Observación**". No asume el rango de un mal. Si la placa costrosa es masiva e intimidada

visualmente en su aspecto estético sucio parental, el único socorro paliativo prescindible recetado es aplicar con algodón friccionado pasivo limpiador de queratina blanda: **Aceite mineral emulsionado / vaselina líquida simple neutra**. (Y no hay prescripción activa). Jamás medicar a un recién nacido corticoide ni champú fungicida duro a esa corta edad ante algo autolimitado perenne.

- **Dermatitis Seborreica en el Adulto (Activa, Invasiva y Crónica):**
- - En esta edad se acribilla al hongo activamente de base con Antimicóticos Tópicos (Aseo semanal local friccionando champú de *Ketoconazol profiláctico al 2% coronario*; o pomadas de un amplio espectro de azoles en sus alas de la nariz facial como *Clotrimazol o Miconazol crema*).
- - Acoplado integralmente a un barrido local desinflamatorio inicial con un paralelo asedio Tópico focalizando base de de Corticoides en las placas para blanquear rápido.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la diferencia clave entre la dermatitis seborreica y la psoriasis del cuero cabelludo?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Dermatitis Seborreica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La dermatitis seborreica es causada por el hongo *Malassezia furfur* en zonas con glándulas sebáceas.
- Las escamas son amarillentas y grasas, a diferencia de la psoriasis que tiene escamas blancas gruesas.
- En el cuero cabelludo las lesiones NO sobrepasan la línea de implantación del cabello.
- La costra láctea en lactantes es la forma infantil de la dermatitis seborreica y no requiere tratamiento.
- La zona facial afectada incluye el surco nasal, zona pernasal y zona ciliar o cejas.
- El ketoconazol en champú es el tratamiento principal para la afectación del cuero cabelludo.
- La diferencia con la psoriasis es clave: la psoriasis sobrepasa la línea de implantación y la seborreica no.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DERMATITIS SEBORREICA)**PREGUNTA 1**

¿Cuál es la diferencia clave entre la dermatitis seborreica y la psoriasis del cuero cabelludo?

- A)** La dermatitis seborreica tiene escamas blancas gruesas y la psoriasis tiene escamas amarillentas
- B)** La psoriasis sobrepasa la línea de implantación del cabello y la dermatitis seborreica no
- C)** La dermatitis seborreica es dolorosa y la psoriasis es completamente asintomática
- D)** La psoriasis se trata con ketoconazol y la dermatitis seborreica con corticoides sistémicos
- E)** La dermatitis seborreica produce alopecia permanente y la psoriasis no afecta el cabello

PREGUNTA 2

¿Cuál es el agente causal de la dermatitis seborreica?

- A)** Staphylococcus aureus colonizando las glándulas sebáceas foliculares
- B)** Propionibacterium acnes en el folículo pilosebáceo en proliferación
- C)** El hongo Malassezia furfur anteriormente llamado Pityrosporum ovale
- D)** El virus del herpes simplex tipo uno que reactiva en zonas seborreicas
- E)** Demodex folliculorum en alta densidad en zonas centofaciales sebáceas

PREGUNTA 3

¿Qué tratamiento se indica para la costra láctea en un lactante sano?

- A)** Ketoconazol en champú al dos por ciento aplicado tres veces por semana
- B)** Corticoides tópicos de baja potencia dos veces al día por dos semanas
- C)** Solo observación ya que la costra láctea es una condición normal que se autolimita
- D)** Antifúngico oral como fluconazol en dosis de peso ajustado por una semana
- E)** Antibiótico tópico con mupirocina para prevenir la sobreinfección bacteriana

RESUMEN: DERMATITIS SEBORREICA

La dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel causada por el hongo *Malassezia furfur*, anteriormente llamado *Pityrosporum ovale*. Se caracteriza por placas eritematodescamativas con escamas de color amarillento o graso, localizadas en zonas con alta densidad de glándulas sebáceas. Las zonas más afectadas son el cuero cabelludo, donde las lesiones NO sobrepasan la línea de implantación del cabello a diferencia de la psoriasis, y la zona facial incluyendo el surco nasal, zona pernasal y zona ciliar o cejas. Esta diferencia con la psoriasis en el cuero cabelludo es un punto clave. En lactantes produce la costra láctea, que es completamente normal y no requiere tratamiento, solo observación. En adultos el tratamiento es con ketoconazol en champú para el cuero cabelludo o clotrimazol en crema para la cara, más corticoides tópicos para reducir la inflamación. La dermatitis seborreica es una enfermedad crónica que tiende a recurrir y requiere tratamientos de mantenimiento.